

氟西汀的不良反应和药物相互作用

喻东山¹, 臧家平²

(1. 南京医科大学附属脑科医院精神科, 210029; 2. 山东省潍坊市精神卫生中心, 262400)

[摘要] 综述氟西汀的拟 5 羟色胺能不良反应、拟去甲肾上腺素能不良反应、心脏不良反应、生殖不良反应、其他不良反应和药物相互作用

[关键词] 氟西汀; 不良反应; 药物相互作用

[中图分类号] R971.43; R969.2

[文献标识码] A

[文章编号] 1004-0781(2005)10-0900-03

氟西汀的不良反应比三环类抗抑郁药 (TCAs) 小, 但并非指氟西汀的各方面不良反应都比 TCAs 为小, 例如, 焦虑性抑郁用氟西汀恶化焦虑和失眠, 而用阿米替林却能改善。所以, 准确认识氟西汀的具体不良反应相当重要。此外, 氟西汀经常与多种药物联用, 可能也会引起或加重不良反应。笔者拟综述氟西汀的不良反应和药物相互作用。

1 拟 5 羟色胺 (5-HT) 能不良反应

1.1 拟 5-HT_{2A} 受体效应

1.1.1 精神迟钝 氟西汀拟 5-HT 通过激动 5-HT_{2A} 受体而抑制前额皮质去甲肾上腺素 (NE) 和多巴胺 (DA) 释放, 引起精神迟钝和全身乏力, 安静时候更明显。

1.1.2 锥体外系反应 氟西汀通过阻断 5-HT 回收而拟 5-HT 能, 通过激动 5-HT_{2A} 受体而抑制黑质纹状体通路 DA 释放, 引起锥体外系反应。表现为震颤、肌纤维颤动、运动过缓、僵硬^[1], 偶有肌张力障碍和静坐不能, 其中静坐不能可能引发自杀观念。在老人、脑损伤、亚临床性帕金森病以及服抗精神病药、卡马西平和锂盐的患者, 服氟西汀更易引起锥体外系反应。如出现帕金森综合征, 应减少氟西汀用量, 换用其他抗抑郁药, 停用抗精神病药和心境稳定药, 用苯海索治疗肌张力障碍, 用普萘洛尔或阿普唑仑治疗静坐不能。

1.1.3 高催乳素血症 氟西汀拟 5-HT 能在下丘脑漏斗多巴胺能通路的突触前膜上激动 5-HT_{2A} 受体, 抑制 DA 释放, 导致 D₂ 受体功能低下; 5-HT 还直接激动突触后膜 5-HT₂ / 5-HT_{1A/1C} 受体, 均致催乳素中度升高^[2], 而催乳素中度升高与乳溢、女性乳房肥大和男性女性型乳房均无显著相关性。^①乳溢: Egberts 等发现, SSR Is 比其他抗抑郁药的乳溢危险性高 8 倍, 帕罗西汀、舍曲林、氟伏沙明和氟西汀已怀疑能引起乳溢^[1]。^②女性乳房肥大: Amsterdam 等 (1997 年) 发现, 用一种 5-HT 再摄取抑制药 (SSR Is) (帕罗西汀、氟西汀、舍曲林) 或文拉法辛至少治疗 1 个月, 59 例妇女中 39% 的有不同程度乳房肥大, 其中帕罗西汀组的乳房肥大率较高, 但与其他组差异无显著性^[1]。^③男性女性型乳房: 最近 1 例单一用帕罗西汀治疗的患者出现男性女性型乳房。Benazzi 又描述了 1 例服氟西汀的男性出现女性型乳房, 可是, 该患者同时服利培酮治疗。由于 5-HT_{1A} 激动药坦

度螺酮 (tandospirone) 能引起男性女性型乳房, 故 SSR Is 引起该不良反应就有了理论根据^[1]。^④乳癌: SSR Is 引起乳癌的相对危险性为 1.8 仅在统计界限上^[1]。

1.1.4 生殖系统 氟西汀拟 5-HT 能通过激动 5-HT_{2A} 受体而抑制 DA 和 NE 释放, 从而抑制性欲、性唤醒和性乐高潮, 其中抑制性乐高潮比抑制性欲和性唤醒明显, 表现为男性射精延迟或不射精, 女性性乐高潮延迟或快感缺失。SSR Is 的拟 5-HT 能由强到弱依次为帕罗西汀、舍曲林和氟西汀, 它们性功能障碍率依次为 47.0%, 36.0%, 17.0%, 表明氟西汀的性功能障碍不良反应比帕罗西汀和舍曲林为轻。处理方法如下。^①等待: 较轻的性功能障碍可随着时间的延长而适应, 其中性乐高潮延迟比性欲和性唤醒减退更易适应。当等待 4~6 个月时, 约 16% 的性功能障碍中度或完全改善。^②药物假日: 氟西汀半衰期为 5 d 当断药 48 h 时, 对性欲减退和性乐高潮延迟无明显改善。^③减药或换药。减药可能缓解性功能障碍, 但增加抑郁症复发率。如换为米氮平, 则无明显性功能障碍。^④对症处理: 射精延迟和快感缺失可选用抗 5-HT₂ 受体药物赛庚啶 4~16 mg·d⁻¹ 或米氮平 15~45 mg·d⁻¹; 拟 5-HT_{1A} 药如丁螺环酮 15~30 mg·d⁻¹; 拟 DA 药如金刚烷胺 100~400 mg·d⁻¹; 拟胆碱药如新斯的明 7.5~15.0 mg 性交前 1 h 服用。快感缺失可选用曲唑酮 50 mg 睡前服。

1.2 拟 5-HT₃ 受体效应

1.2.1 头痛 氟西汀拟 5-HT 能, 5-HT 引起血管壁无菌性炎症, 通过一种受体 (可能是 5-HT₃) 引起脑部血管收缩, 血流量下降, 缺血缺氧, 导致头痛, 可用复方对乙酰氨基酚 (止痛片) 处理。氟西汀还间接拟 NE 能, 从而激动 α₁ 受体而收缩血管, 对头痛也起作用, 故氟西汀的头痛发生率是帕罗西汀的 2 倍。

1.2.2 心率减慢 SSR Is 拟 5-HT 能, 有可能是通过激动 5-HT₃ 受体而抑制 DA, 从而抑制 β₁ 受体 (DA 也对 β 受体有激动作用), 中度减慢心率, 氟西汀平均减慢 6 次·min⁻¹, 这对正常人无临床意义, 但对窦房结疾病患者可引发窦性心动过缓。

1.2.3 消化系统 ^①畏食: 氟西汀通过拟 5-HT 能激动 5-HT₃ 受体, 引起畏食, 可加重抑郁症原有的畏食, 畏食在老人可引起低钠血症^[2,3];^②胃肠反应: 氟西汀拟 5-HT 能, 通过激动 5-HT₃ 受体引起恶心呕吐, 通过激动 5-HT₄ 受体而促进乙酰胆碱释放, 引起腹痛、腹泻, 这在惊恐障碍中最易感。最近, 美国礼来公司生产一种氟西汀分散片 (百忧解), 服后在胃中迅速崩解, 均匀分布在胃壁上, 可能减少对胃黏膜的刺激, 改善胃肠反应。

[收稿日期] 2005-02-21

[作者简介] 喻东山 (1960—), 男, 湖北黄梅人, 副主任医师, 硕士, 主要从事临床精神病学研究工作。

2 拟 NE能不良反应

2.1 焦虑和失眠 γ 氨基丁酸 (GABA)神经细胞体上有一种 5-HT_{2C} 受体,激动该受体能兴奋 GABA 神经元,从而抑制 NE 神经元。氟西汀直接阻断 5-HT_{2C} 受体,从而抑制 GABA 神经元,引起 NE 神经元脱抑制性兴奋。许多研究证实,氟西汀增加额叶皮质和下丘脑的 NE 水平^[4]。故比其他 SSRIs 易引起焦虑和失眠。SSRIs 选择性阻断 5-HT 回收是相对的,多少还阻断 NE 回收,其中阻断 NE 回收比阻断 5-HT 回收的比率由强到弱依次为氟西汀、舍曲林、帕罗西汀和西酞普兰。由此可见,氟西汀在 SSRIs 中该比值最强,故最易引起焦虑和失眠,其发生率为 $10\%\sim 15\%$,约 5% 患者因此而中断治疗。一旦氟西汀致焦虑,可换成舍曲林处理。

2.2 体重减轻 氟西汀因焦虑、失眠和畏食效应而引起体重减轻。但随着时间的延长,逐渐可以耐受,故 6 个月后体重减轻效应不再明显,长期治疗反而增加体重。

2.3 无外周交感神经兴奋效应 氟西汀有拟 NE 能效应,理论上可引起外周交感神经兴奋,包括心动过速、高血压、口干和便秘,但实际上氟西汀并无这些不良反应。可能是因为氟西汀通过抑制 GABA 能而间接激动 NE 能,这在中枢能实现,在外周不能实现。相反,文拉法辛通过阻断 NE 回收,增加中枢和外周 NE 能,故可引起心动过速、高血压、口干和便秘。

3 心脏不良反应

3.1 传导阻滞 氟西汀治疗不影响 QRS 或 QT 间期,故罕见发生传导阻滞及相关死亡,即使发生,也是在极高剂量或联合其他药物时。

3.2 心律失常 氟西汀无任何抗心律失常效应。有报道氟西汀显著增加室性期前收缩,但因为室性期前收缩的变异性本身很大,故难以定论。

3.3 出血 氟西汀降低血小板 5-HT 水平,偶尔引起少量出血。因为出血与心肌梗死后死亡相关联,故宜引起注意。

4 生殖不良反应

Chambers 等 (1996 年) 前瞻性研究发现,妊娠后 3 个月服氟西汀,可增加早产及新生儿期适应性降低、喂食时发绀和神经过敏发生率。

5 其他不良反应

190 例通过乳汁接触氟西汀的病例,有 89 例血药浓度在未检出,或者 $<340\ \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$; 180 例未出现不良反应,剩下的 10 例有过度哭闹、睡眠减少、呕吐和腹泻,停止哺乳后消失。氟西汀持续治疗引起的变态反应率比舍曲林和帕罗西汀高,约 2%,表现荨麻疹,可伴发热、关节痛和淋巴结痛,通常在治疗 2~3 周出现,断药后 0.5~2.0 周消失。氟西汀还可引起出汗,但机制不明。由于赛庚啶 $4\sim 8\ \text{mg}\cdot\text{d}^{-1}$ 可治疗出汗,故可能与拟 5-HT 能有关。氟西汀单独过量罕见致死,1 例患者曾服氟西汀 $3\ 000\ \text{mg}\cdot\text{d}^{-1}$ (相当于 $20\ \text{mg}\times 150$ 片),仅出现 2 次一过性癫痫发作,随后康复。

6 药物相互作用

6.1 单胺氧化酶抑制药 (MAOIs) 氟西汀不可与 MAOIs 联用,不然易引起 5-HT 综合征。机制是 MAOIs 抑制单胺氧化酶

(MAO) 活性,MAO 本来是降解 DA、NE 和 5-HT 的,当 MAO 被抑制后, 5-HT 积蓄,加上氟西汀增加 5-HT 能,导致 5-HT 功能亢进,表现为 5-HT 综合征。主要表现:①精神症状,情绪激动、精神错乱、谵妄或昏迷;②神经症状:僵硬、肌痉挛、反射亢进、震颤;③交感神经症状,高热、出汗、寒战、多动、自主神经功能不稳和生命体征改变;④副交感神经症状:恶心、呕吐及腹泻。一旦出现 5-HT 综合征,应停用所有拟 5-HT 能药物,用抗 5-HT 能药物赛庚啶 $4\ \text{mg}\ \text{tid}$ 有的患者使用 2~5 次症状即可缓解,必要时用支持疗法。预防措施:在停用 MAOIs 2 周后,才可用氟西汀;在停用氟西汀 5 周后,才可用 MAOIs^[5]。在氟西汀停用 5 周期间,为防止抑郁复发,可换用半衰期较短的 SSRIs (如氟伏沙明),这样可使无 SSRIs 治疗的时间缩至 1 周。

6.2 其他 SSRIs 药物 Nelson^[6] 指出 SSRIs 联合 SSRIs 不合理。合理的药物联用是联合不同作用机制的药物,以提高疗效,而联用主要机制类似的药物则达不到这一目的。但也有人主张,SSRIs 的某些次要机制不同,如帕罗西汀有弱 NE 效应,舍曲林有弱 DA 效应。可是,这些次要效应很弱,无明显临床意义。笔者认为,氟西汀引起唤醒,氟伏沙明引起思睡,在强迫症患者中通常需要治疗量较高,单用氟西汀可能出现烦躁,单用氟伏沙明可能出现思睡,故可以早上服氟西汀 $20\ \text{mg}$ 晚上服氟伏沙明 $100\ \text{mg}$ 。当然这种联用要考虑到 5-HT 能的叠加作用,故每种药物用量为 $<50\%$ 的最大治疗量,以避免 5-HT 综合征的发生。

6.3 TCAs 当氟西汀与 TCAs 联用时,可使 TCAs 血药浓度升高 >2 倍,故当氟西汀联合 TCAs 时,TCAs 使用量应极低 (如 $50\ \text{mg}\cdot\text{d}^{-1}$),以免造成严重后果,包括谵妄、癫痫发作和心脏传导阻滞。

6.4 典型抗精神病药 氟西汀激动 DA 神经元突触前膜上的 5-HT_{2A} 受体,抑制 DA 释放,强化抗精神病药的 DA 的 D_2 受体阻断,当强化中脑边缘通路上的 D_2 受体阻断时,可能强化抗精神病疗效;当强化黑质纹状体通路上的 D_2 受体阻断时,可能强化锥体外系反应;当强化下丘脑漏斗通路上的 D_2 受体阻断时,可能强化高催乳素血症。从药动学来看,吩噻嗪类药物 (如氯丙嗪、甲硫哒嗪)、丁酰苯类药物 (氟哌啶醇)、硫杂蒽类药物 (如三氟噻吨) 经肝脏细胞色素 $P_{450}\ 2D6$ 同工酶代谢,氟西汀抑制该酶^[1],导致这些抗精神病药代谢受阻,血药浓度升高,可增加相应疗效及不良反应。

6.5 利培酮 从药效学上看,氟西汀激动 DA 神经元突触前膜上的 5-HT_{2A} 受体,可强化抗精神病效应、锥体外系反应和高催乳素血症。从药动学上看,利培酮经细胞色素 $P_{450}\ 2D6$ 酶代谢,氟西汀抑制该酶,从而抑制利培酮代谢,升高其血药浓度,也增加其抗精神病疗效及不良反应 (锥体外系反应和高催乳素血症)。

6.6 拟 DA 药物 SSRIs 抑制 DA,可能阻碍抑郁的康复。临床报道提示,DA 激动药丁氨苯丙酮可用于氟西汀难治的重性抑郁症,并通过增加 DA 而“纠正”SSRIs 的抗 DA 不良反应^[6]。

[参考文献]

[1] Dansa C, Bianchi-Demicheli F, Vilahet P, et al. "Dopamine de-

endent" side effects of selective serotonin reuptake inhibitors : a clinical review [J] . J Clin Psychiatry 2004 , 65 (8) : 1064 — 1066 .

[2] Keshavan M S Kennedy JS Drug-induced Dysfunction in Psychiatry [M] . New York : Hemisphere Publishing Corporation 1992 . 93 — 101 .

[3] Rabheni K . Special issue in the management of depression in older patients [J] . Can J Psychiatry 2004 , 49 (Suppl 1) : 41 — 49 .

[4] Lett H S Blumenthal J A Babyak M A et al . Depression as a risk factor for coronary artery disease : evidence mechanisms and treatment [J] . Psychosomat Med 2004 , 66 (3) : 305 — 315 .

[5] Gummick J F Nemeroff C B . Problems with currently available anti-depressants [J] . J Clin Psychiatry 2000 , 61 (Suppl 10) : 5 — 15 .

[6] Nelson J C . Managing treatment - resistant major depression [J] . J Clin Psychiatry 2003 , 64 (Suppl 1) : 5 — 12 .

1999~2003年广州地区精神科药物使用情况分析

杨婵娟,邱 畅,赵素华,刘玉平,温预关
(广州市精神病医院精神科, 510370)

[摘要] **目的** 了解精神科药物的使用情况、发展趋势。**方法** 对 1999~2003年广州地区的精神病专科医院、综合医院的精神科、心理门诊的精神科处方药物进行调查分析。**结果** 2000~2003年广州地区的精神科药物消耗总金额年增长率分别为 25.16%, 30.94%, 24.90%, 26.40%;精神科经典药物消耗总金额的年增长率分别为 10.78%, 6.08%, 3.85%, 3.46%;精神科新型药物消耗总金额的年增长率的分别为 26.93%, 33.61%, 26.69%, 28.00%。**结论** 精神科新型药物的使用已逐渐成为治疗精神疾病的首选药物。

[关键词] 精神科药物;金额;用药分析

[中图分类号] R971 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1004-0781(2005)10-0902-02

为了解精神科药物在广州地区的使用情况及发展趋势,笔者对本地区的精神病专科医院及影响较大的 10家综合性医院精神科用药进行调查。笔者将调查的药物进行如下分类:经典的精神科药物包括 4种抗抑郁药物(阿米替林、麦普替林、氯丙米嗪、多塞平)和 5种抗精神病药物(奋乃静、氟哌啶醇、氯丙嗪、氯氮平、舒必利),新型的精神科药物包括 7种抗抑郁药物(氟西汀、舍曲林、帕罗西汀、西酞普兰、氟伏沙明、瑞美隆、曲唑酮)和 3种抗精神病药物(利培酮、奥氮平、奎的平)^[1],这些均为进口或中外合资药。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 资料 按年度收集 1999~2003年广州地区精神病专科医院和 10家综合性医院常用的抗精神病和抗抑郁两种精神科药物的使用量及消耗金额。其中专科医院 2家(广州市精神病医院、白云精神康复医院),综合医院 10家(广东省人民医院、中山大学医学院附属医院 3家、广州市第一人民医院、广州医学院附属医院 2家、南方医院、珠江医院、华侨医院);常用抗抑郁

药物 11种(阿米替林、麦普替林、氯丙米嗪、多塞平、氟西汀、舍曲林、帕罗西汀、西酞普兰、氟伏沙明、瑞美隆、曲唑酮),抗精神病药物 8种(奋乃静、氟哌啶醇、氯丙嗪、氯氮平、舒必利、利培酮、奥氮平、奎的平)。

1.2 方法 建立数据库,统计内容包括医院、药名、剂量、剂型、包装、价格、总用量等情况。计算 5 a内每种药物的每年使用量、总金额、变化频率,并将专科医院与综合医院,经典药物与新型药物进行比较。分析 5 a用药的变化情况,精神科药物的使用分布状况,了解用药动态,预测发展趋势。

2 结果

2.1 专科医院与综合医院药物消耗金额情况 5年来专科医院与综合医院精神科药物的消耗总金额变化情况见表 1、2。由表 1可见,无论是综合医院还是专科医院 1999~2003年精神科药物的消耗总金额均在逐年增长,两种医院精神科消耗的药物的基本平衡。由表 2可见,两种医院的消耗总金额增长速度基本稳定,经 t检验,增长速度差异无显著性 ($P>0.05$)。

表 1 1999~2003年专科医院与综合医院精神科药物的消耗总金额变化情况 万元

医院类型	1999年		2000年		2001年		2002年		2003年	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
专科医院	740.91	54.05	897.92	52.34	1 134.52	50.50	1 402.26	49.98	1 759.84	49.62
综合医院	629.79	45.95	817.69	47.66	1 111.95	49.50	1 403.58	50.02	1 786.75	50.38
合计	1 370.70	100.00	1 715.61	100.00	2 246.47	100.00	2 805.84	100.00	3 546.59	100.00

表 2 2000~2003年专科医院与综合医院精神科药物的消耗总金额年增长率 %

医院类型	2000年	2001年	2002年	2003年
专科医院	21.19	26.35	23.59	25.50
综合医院	29.84	35.99	26.22	27.30
总额年增长率	25.16	30.94	24.90	26.40

2.2 经典精神科药物与新型精神科药物消耗金额情况 结果

见表 3、4。由表 3可以看出,各类药物消耗金额在 5 a内均有增长,新型精神科药物占总金额 $>90\%$,这可能与新型药物的单价高于经典药物数倍有关。如奋乃静日剂量 20 mg 消耗 0.283元,而利培酮日剂量 4 mg 消耗 12.48元。由表 4可见,新型药物的增长明显快过经典药物,经典药物增长速度有逐年下降的趋势。